DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2025-01-003

# 汉语失语症患者互动的会话分析研究

马文[1] 杨信信[2]

(1. 山东大学 外国语学院,山东 济南 250100;
2. 谢菲尔德大学 健康科学学院, 英国 谢菲尔德 S10 2TS)

[摘要] 失语症是由大脑烱造病变(如中风、脑肿瘤、脑损伤)引起的获得性语言障碍。20 世纪 90 年代,国外(尤其英语国家)开始从会话分析角度对失语症展开研究,其研究成果已被广泛应用到失语症的临床干预中。然而在中国,对汉语失语症患者的研究仍主要局限于神经科学、心理学等领域,虽有少量语言学研究,但鲜见对失语症人群沟通的会话分析研究。本文聚焦于互动中的会话修正现象,通过对 30 名失语症患者近 1000 分钟在日常与机构场景中的会话分析,深入探究失语症引发的修正如何影响汉语患者与家人及医务工作者交流中的会话序列结构及话轮构建。研究发现找词障碍通常触发失语症说话者自启修正,理解表达障碍更容易触发他启修正。自启修正导致会话话轮延长,他启修正则容易引起序列扩展。本研究旨在为临床话语研究拓展新角度,为探索如何增进失语症病人的社会关怀,提高失语症病人生活质量提供启示。

[关键词] 失语症;会话分析;会话修正;话轮;序列

[中图分类号] H030 [文献标识码] A [文献编号] 1002-2643(2025)01-0019-12

# Conversation Analysis of Interactions Involving Mandarin Speakers of Aphasia

MA Wen[1] YANG Xinxin[2]

(1. School of Foreign Languages and Literature, Shandong University, Jinan 250100, China;
2. Human Communication Sciences, University of Sheffield, Sheffield S10 2TS, UK)

**Abstract**: Aphasia, an acquired language disorder caused by brain damage, has been studied through conversation analysis in Western countries since the 1990s, aiding clinical interventions. However, in China, research on aphasia in Mandarin-speaking patients has focused primarily on neuroscience and

**收稿日期**:2024-09-12;**修改稿**:2024-11-28;**本刊修订**:2025-01-09

**基金项目**:本文为国家社科基金项目“中国老年人语言退化及障碍干预的临床语言学研究”(项目编号:21BYY020)、山东省社科规划研究重点项目“中国老年人语用障碍的临床语言学研究”(项目编号:21BYYJ01)和国家社科基金重点项目“面向认知障碍相关脑疾病的中国临床话语分析理论体系构建研究”(项目编号:22AZD155)的阶段性成果。

**作者简介**:马文,博士,教授,博士生导师。研究方向:临床语言学、会话分析、人文医学。电子邮箱:mawen@sdu.edu.cn。杨信信,博士。研究方向:临床语言学、会话分析、言语障碍。电子邮箱:xyang105@sheffield.ac.uk。

**引用信息**:马文,杨信信.汉语失语症患者互动的会话分析研究[J].山东外语教学,2025,(1):19-30.



中国知网 https://www.cnki.net

psychology. This study, with focus on conversational repair, analyzes nearly 1000 minutes of conversations involving 30 aphasia patients in daily and institutional settings, exploring how repair practices impact turn and sequence structures in interactions with family and healthcare workers. Findings show that word-finding issues often trigger self-initiated repairs, extending turns, while comprehension difficulties more frequently lead to other-initiated repairs, expanding sequences. This research offers a new perspective for clinical discourse studies, providing implications on social care and support for individuals with aphasia.

**Key words**: aphasia; conversation analysis; conversational repair; turn; sequence

## 1. 引言

失语症是由大脑局部损伤引起的言语障碍,临床上根据言语症状及大脑受损部位分为不同类型(如运动性失语、感觉性失语),其表现包括找词困难、言语错乱等(Law et al., 2015; 高素荣,2006)。失语症多发于老年人,患者平均年龄 66 岁,且随着年龄增大,发病率和死亡率随之升高。在我国,60 岁以上人群脑卒中占总病例的 81.31%(王拥军等,2020),而脑卒中是失语症的主要原因。近年来,老年失语症话语逐渐成为老年语言研究的重要组成部分。本文将通过会话分析(conversation analysis)的研究方法考察失语症患者是如何通过会话互动及修正应对言语障碍、完成互动任务的,旨在为临床话语研究乃至老年话语研究提供新视角,并对提升失语症患者的社会关怀和生活质量提供启示。

## 2. 文献综述

会话分析是一种质性研究方法,该研究方法以自然会话为载体,描述人们如何通过会话按照一定秩序完成社会行为,并试图理解在互动中创造这种秩序的隐性规则、意义或结构 (Sacks et al., 1974)。20 世纪 90 年代会话分析开始被应用到失语症研究中(Lesser & Milroy,1993),颠覆了以往对失语症患者言语障碍为导向的研究局限,研究者开始将重点放在失语症患者在日常生活中的真实交流情况,而非其测试性言语表现,重塑了失语症患者作为一个交流者而非言语障碍患者的身份属性。

在失语症的会话研究中,会话修正(conversational repair)是最为重要的主题之一(Wilkinson et al., 2020)。一般会话中,自我修正通常速度快且易成功(Schegloff et al., 1977),但失语症患者的自我修正冗长且不易成功。由于找词困难,失语症患者的话轮中经常出现停顿、拖延、动作、叹词以及刻板性话语等(Laakso,2014),这些语言及非语言行为为患者完成自我修正准备时间,也为会话伙伴进入话轮修正提供了契机。当失语症说话者的话语难以理解或他自我修正失败时,会出现他启修正,常见的由他人发起的修正引导方式有开放式修正引导(“什么?”“嗯?”)、重复修正源及理解核对(比如“你意思是××吗?”)等(Schegloff et al., 1977)。Schegloff et al. (1977)认为,在一般会话中,自我修正优先于他人修正。但在失语症会话这种特殊不对称对话中,该原则被打破,常常是言语能力正常的一方实施修正 (Wilkinson, 2007)。



中国知网 https://www.cnki.net

国外对失语症的修正研究表明,会话对象的他人修正在失语症会话中具有重要意义,失语症会话中常见的他人修正引导方式为理解核对(Beeke et al., 2020),最少使用的修正引导方式是开放式修正(Barnes & Ferguson, 2015),因为开放式修正引导既不能定位修正源位置,还会把会话任务重新交给患者,使会话效率降低。此外提供/提示目标词汇、补充不完整语法结构等也是失语症会话常见的他人修正引导方式(Laakso, 2015)。前期研究表明,自启修正在找词困难引发的会话中发起频率较高,且容易失败,主要表现为患者发出情态表达如消极感叹语等。他启修正则主要是通过会话伙伴合作共建话轮的方式发起,修正序列主要表现为猜测序列结构或较短的更正序列结构,强调会话伙伴的重要性。

综上所述,失语症患者会话互动的会话分析研究已经取得了一系列可喜的研究成果,然而相关研究成果大都集中于英语国家,汉语环境下失语症患者的会话分析研究尚在起步中。本文将聚焦于失语症互动中的会话修正现象,旨在揭示在汉语失语症患者与其医疗或陪护人员的互动中,会话双方是如何通过言谈共同应对失语症患者的言语障碍的,以及在处理互动中的言语障碍的过程中,会话的话轮及序列结构呈现出哪些特殊性。

## 3. 研究方法

### 3.1 研究对象

本研究共视频录制了30名老年失语症患者在不同场景下的互动语料,这些患者均保持了一定的言语互动能力,非完全性失语。在医院场景中,患者与康复师、护士及医生等医务工作者进行交流;在家庭场景中,选择了6名患者与其家人或朋友的日常会话。所有数据采集过程均符合伦理规范,医院录制数据通过了相关机构的伦理审查,家庭场景的录制获得了患者及其家属的知情同意。

### 3.2 语料收集与转写

语料采集过程中使用了高质量录音/像设备,确保录像的清晰度便于后续分析。会话转写采用了Jefferson(2004)的系统,以细致、准确地捕捉会话细节。总计约1000分钟的会话录音被收集并转写。转写过程中严格遵循转写规范,确保每个话轮、停顿、重复和修正等细节得以完整呈现,为分析提供可靠依据。

### 3.3 语料分析

语料分析侧重于失语症会话中的自我修正与他人修正如何在两个维度上影响会话结构:横向上,观察患者如何通过自启修正构建话轮;纵向上,分析会话伙伴如何通过他启修正更新序列结构。语料分析部分将对此展开详细阐述。

## 4. 失语症会话的话轮延伸与序列扩展

### 4.1 找词困难对话轮构建的影响——话轮延伸

话轮一般由一个或几个话轮构建单位组成(Schegloff,1996),失语症导致的找词困难



中国知网　https://www.cnki.net

或其他言语障碍对当前话轮向话轮转换位置的推进造成延迟。对于单一话轮构建单位组成的话轮,失语症患者主要是通过对单一话轮构成单位的不断尝试延迟话轮的进程。对于由几个不同话轮构建单位组成的话轮,其主要延迟的是下一个话轮构建单位的出现,从而延迟整个话轮结束的时间。以下分析分别基于单话轮构建单位话轮和多话轮构建单位话轮探究失语症是如何导致延展说话人话轮、拉长整个话轮构建时间的。

**例 1**

001　护 06：　你最近锻炼的时候,那胳膊,腿疼不疼啊

→　**002　患 04：　胳:膊:「(.)这次,　　嘶：　哎呀,这次,((哎!))**

**⌊((伸开左腿,然后伸开右腿))**

→　**003　哎:! 这次,/zou/一个(.)「比较疼⌉**

**⌊((点头))⌋**

004　护 06：　比较疼啊

005　患 04：　嗯

006　护 06：　就是锻炼起来有点累,是不是

007　患 04：　对,对,对,对

在该会话中,第 1 行,护士询问患者“你最近锻炼的时候,那胳膊,腿疼不疼啊”,该问句为是非问句。按照会话的优先原则(preference),患者应该在回应中给出一个配套型答案(type-conforming answer)(Stivers, 2010),即“疼”或“不疼”,但是实际会话中患者给出的回应并未遵循优先原则。本该是“疼”或“不疼”的答案被扩展成“胳:膊:(.)这次,嘶:哎呀,这次,((哎!))哎:! 这次,/zou/一个(.)比较疼”。失语症患者的回应先是拖长声音的话轮单位“胳:膊:”,然后是伸腿动作,伸腿动作完成后下一个话轮构建单位“这次”出现,但因为找词困难,目标词汇被象声词“嘶”和感叹语“哎呀”延迟。之后,失语症患者重复第二个话轮构建单位“这次”试图再次推进话轮,感叹语等非言语行为再次取代目标词汇的出现。说话者第二次重复第二个话轮构建单位“这次”尝试话轮推进。以上几次话轮推进为寻找目标词汇争取了时间,患者在第三次重复“这次”后找到了目标词汇,目标词汇输出后,话轮构建结束。在上述多话轮单位构成的话轮中,话轮扩展主要因为找词困难延缓了下个话轮构建单位的出现,患者出现多次自我修正尝试。虽然重复使用同一话轮单位及感叹语等扩展了当前话轮,延缓了话轮向话轮转换位置推进的时间,但相对于话轮内停顿或直接放弃话轮,以上会话行为展示了失语症患者作为会话者的交流能力,一方面在于其会话保持了一般会话的连续性;另一方面在于失语症患者作为说话者本身意识到自己言语问题,并通过感叹语来表明自己对待这些言语问题的态度。

**例 2**

001　康 10：　你确定一下它是什么

**002　患 14：　是/diyuan/,那个,嗯:第一吧,那个叫**

003　康 10：　说第一个



中国知网　https://www.cnki.net

→ 004　患 14：　**那个,那个,那个,叫 wang-wangpan (4.7)((哎))！哎呀**
→ 005　　**((*谩骂*)),又想不起来了**
006　康 10：　>°又想((笑声))不起来了°<,不要着急,不要着急
007　　(0.9)
008　　你想-你想确定它是蝴蝶?
009　患 14：　不是
010　康 10：　垃圾
011　患 14：　不是
012　康 10：　虫子
013　患 14：　「　　哎　　」
　　⌊((*看向康复师*))⌋

对于单一构建单位构成的话轮,其话轮构建往往由于找词困难经过多次重复尝试后失败。在例 2 中,失语症患者 14 同例 1 一样,在不断自我修正寻找目标词汇,但不同于上个患者,失语症会话者 14 到话轮结束也没找到目标词汇。国外会话分析研究者(Wilkinson et al. , 2003; Beeke et al. , 2020)认为,患者在找词时会通过眼神等非言语社会行为邀请会话对象进入话轮帮助其找到目标词汇,也可以不依靠会话对象自己完成找词。当失语症发话者依靠自己找词但又由于言语障碍不能完成找词时,会使用元语言评论及相关社会行为放弃找词(Wilkinson, 2007)。

在此例中,康复师提问图片内容,正确答案应为“虫子”,但患者在第 2 行回答“是/diyuan/”,出现错语。尽管患者尝试自我修正,但进展缓慢,第二次回答“第一吧”在多个找词标志语“那个”和“嗯:”之后才出现。随后,患者继续尝试并输出“/wang-wangpan/”,但双方均知这非目标词汇。之后,患者持续注视屏幕,找词仍在进行(Laakso & Godt, 2016)。尝试寻找 4.7 秒后,患者发出一系列情态感叹语,最终,患者通过感叹和“想不起来了”示意放弃,结束话轮。在本例中,单一话轮构建单位构成的话轮因持续找词困难而被多次重新构建,本应该 1 个话轮构建单位就可以结束的话轮,患者共进行了 14 次话轮构建尝试,话轮不仅被重新构建,而且被反复重新构建,反复重新构建的话轮延长了会话向话轮转换位置的推进时间,话轮被横向拉长。但原话轮的放弃与新话轮的重建之间总有找词标志语填充,一定程度上保持了会话的连续性。

例 1 和例 2 分别展示了失语症如何对会话者言谈中的单话轮构建单位话轮以及多话轮构建单位话轮的话轮构建造成影响。在单话轮构建单位话轮的构建中,失语症说话者因找词困难反复自启修正,反复的自启修正失败导致话轮多次重新构建,推迟了话轮的结束,横向扩展了话轮。在多话轮构建单位话轮的构建中,失语症一方面影响单个话轮构建单位内组成部分的输出,另一方面影响说话者输出下一个话轮构建单位,从而延迟整个话轮结束的时间。

### 4.2 理解表达障碍对序列结构的影响—序列结构扩展

失语症及其导致的言语困难决定了会话对象在交流中的重要作用,会话对象在会话



中国知网　https://www.cnki.net

中可能通过他人修正与失语症患者共同构建会话序列（Barnes & Ferguson, 2015），完成会话行为。他人发起修正是会话对象与患者沟通最常使用的交流方式（马文，2003；姚剑鹏，2016）。在汉语语料中，他人发起修正通过两种方式扩展会话序列。其中一种是由于同一修正源（repairable）持续不被理解引发的对同一问题的反复修正（例 3），另一种是会话过程中不断出现的修正源引发的对不同问题的多次修正（例 4）。

**例 3**

04:36 001 护 05： 原来是做什么工作的
002 患 15： (.)(退休)(.)/lianbing/ (.)(法院)
→ 003 护 05： 是在工厂里吗
004 患 15： ((*挥手*))
005 护 05： 不是
006 患 15： /huaibian/
→ 007 护 05： >/huaibian/< 兵，当兵
008 患 15： ((*挥手*))
009 护 05： 也不是
→→ 010 患 15： /huaibi(h)an/
011 护 05： ((*笑声*))
012 患 15： 「 /huaibi(h)an/ 」
└((*身子前靠*))((*食指两次敲击桌子*))┘
013 护 05： (.)
014 患 15： /huaibi(h)an/
→ 015 护 05： (.)°/huaibian/°, /huaibian/, /huaibian/是什么
016 患 15： /huaibi(h)an/
→ 017 护 05： ((*看向斜前方*))「°/bai mian/°」
└((*看向患者*))┘
018 患 15： /dianrou/
→ 019 护 05： 电工？
020 患 15： ((*食指敲桌子*))
021 护 05： 不是，哦，我猜猜这还是啥，不是教书
022 患 15： 嗯
023 护 05： 不是电工
024 患 15： 嗯
025 护 05： 也不是工人
026 患 15： 嗯
027 护 05： 昂：那还有啥，我想想哈，还有啥，办公室



中国知网 https://www.cnki.net

028　患 15：　嗯
029　护 05：　坐办公室
030　患 15：　啊
031　护 05：　啊:不是会计
032　患 15：　((*食指敲两次桌子*))
033　护 05：　不是会计
034　患 15：　嗯
035　护 05：　写东西的
036　患 15：　哎!((笑))
037　护 05：　是吧
038　患 15：　哎!((笑))
039　护 05：　啊:文秘
040　患 15：　(°文秘°)⌈/caigou/　　⌉
　　⌊((*食指连续敲桌子*))⌋
041　护 05：　啊
042　患 15：　/caigou/
043　护 05：　那你累不累

在例 3 中,问题—答案序列被大幅扩展,原本应该由 2 个话轮构成的最小相邻对由于失语症导致的输出内容难以理解不断引发他人修正,最终被扩展为 42 个话轮的序列(Schegloff, 2007),且仍未得到答案。护士第 1 行提问,患者第 2 行回应,但因其内容无法理解,引发第 3 行护士的理解核对。患者以挥手否认,但护士未进一步核对,而是用语言释义患者动作。在失语症患者参与的对话中,患者通常用动作补偿言语缺失,这显示了他们具备“授权”能力,但需他人将其转化为语言表达(Goffman, 1979)。此“授权-演绎”构成一个旁侧序列(Schegloff, 2007)。

旁侧序列结束后,患者多次尝试自我修正,但各次修正内容几乎无差异,导致护士难以获取有效信息。在第 7 行,护士提供了猜测性答案“兵,当兵”,被患者否认。随后,护士将患者的动作补偿转化为语言,序列再次延展。经过两次失败的他人修正后,患者再次尝试自我修正,但因语言障碍,只是重复了之前的内容,并伴随笑声,显示其对自身言语困境的意识(Wilkinson, 2007)。

在第 12 行,患者靠近桌子并用食指敲击两次,暗示目标词可能为两个词汇的短语。尽管信息有所增加,第 13 行短暂停顿表明护士仍无法理解,患者第 14 行再以笑声重复答案,邀请护士修正。此后形成的“猜测序列”进一步缩小目标词汇范围(Laakso & Klippi, 1999),但仍未成功。

在 35-38 行,出现“坐办公室”和“写东西的”等猜测,最终仍未得到答案,序列因多次猜测失败而中止。第 41 行,护士对患者的自我修正进行“序列剔除”(sequential



中国知网　https://www.cnki.net

deletion),转而发起新话题“你累不累”。

**例 4**

001 家属 1: 你跟着过去那个老师姓什么来
002 患 01: 李大亮
003 家属 1: 啊,李大亮
004 患 01: 对
005 家属 1: 给-给-上他家给他看孩子
006 患 01: 嗯,对,李大亮
007 家属 1: 人不错
008 患 01: 嗯:人不错,对,他-他,呃,也,不太很胖啊,也挺
009 瘦的他,在,脸,圆圆的,挺赛,李大亮,然后:呃:
→ 010 家属 2: 声音这么小呢
011 患 01: 呃:当时在那个
→ 012 家属 1: 声音大点儿说话
013 患 01: 声音-不是,那时候,在那个李大亮,他在那里干了
014 一年,有铁路/f/(.)分
→ 015 家属 1: 分行
016 患 01: 分行,某某分行
→ 017 家属 1: 某行某某分行
018 患 01: 又上了某行,然后干了一年,后来我那个:
→ 019 家属 1: 某行筹资部
020 患 01: 某行筹资部,然后上了那个某分行,我就打字儿啊
→ 021 家属 1: 办公室
022 患 01: 办公室,那个,那个叫,那个,叫,那个,呃,
023 洪春雨嘛,那个老师,他-他,那个,干了有四五年,
024 然后就那个,在某行,就离职啦,呃,就是这么多吧

例 3 是会话对象针对同一个修正源发起的多次修正,例 4 是会话对象针对不同的修补源发起的修正。两种他人修正方式都在一定程度上扩展了会话的序列结构。例 4 中,第 9-10 行,11-12 行,14-15 行,18-19 行,及 20-21 行,都是患者有言语困难时非失语症说话者进入患者话轮进行修正。如第 9 行,当患者出现拖音和找词标志语如“然后:呃:”时,家属 2 在第 10 行进入话轮发起修正“声音这么小呢”,在他人发起修正后,患者下一行进行了自我修正,但患者的音量并未因修正而发生变化,引发了 12 行家属 1 的再次修正。修正进入话轮的位置是患者再次发出找词标志“那个”时。同样在 13-14 行,当失语症患者话轮出现言语障碍,如“分行”的第一个音素/f/和停顿引发的产出困难,家属 1 进入话轮进行修正。



中国知网 https://www.cnki.net

在失语症会话中,我们有以下发现:第一,自我修正仍是优先行为,他人修正一般在自我修正缺失/失败后出现(Schegloff et al. , 1977)。无论失语症患者会不会针对他人发起的修正进行自我修正,其自启修正话轮不会被其他说话者占用。家属 2 在第 10 行发起修正后,患者 11 行并未自我修正(提高声音)而是继续(以原来的音量)当前话轮,12 行家属 1 的修正发起是在患者 11 行缺乏自我修正的情况下再次被引发的,所以自启修正优先于他人修正。第二,修正一般发生在患者出现言语障碍的位置。除上述所说序列外,第 19 行家属 1 的修补发生在找词标志语"那个"出现之后,但修正源"某行"却在话轮起始部分,虽然修正源在准确度上有问题,但其在语法及语义构成方面完整,没有引起理解偏差,所以修正源一开始出现时,家属 1 并未修补,但当找词困难出现时,家属 1 进入患者话轮对两个话轮构成单位之前的修正源进行了修补。因此,失语症患者的话轮构建相对脆弱,话轮常常不能过渡到话轮转换位置(Sacks et al. , 1974)就因他人修正被取代,序列也因此被扩展。扩展的修正序列表现为:失语症说话者的问题话轮(第 9,11,13,18,20 行)—非失语症说话者的修正话轮(第 10,12,15,19,21 行)—失语症说话者接受修正话轮(第 11,13,16,20,22 行)。虽然该序列结构与例 3 相比相对简化,但此序列结构反复出现,会话向序列结束位置的推进被延长,会话序列大幅扩展。

例 4 中,第 17 行非失语症说话者对患者的接受修正话轮(第 16 行)持续修正,虽然修正扩展了当前修正序列,但此次修正并非因会话双方未达成互解,而是一种更正产出序列(correct production sequence),这种序列可以凸显失语症患者的"言语不能",是国外语料失语症会话中常见的一种具备教育性特质的序列结构(Lock et al. ,2001),这种序列结构在目前我们掌握的汉语语料中很少出现。汉语语料中,会话序列的展开一种是由于同一个问题持续不被理解引发的反复修正(例 3);另一种是会话过程中不断出现的修正源引发的多次修正(例 4)。本段会话中,失语症患者在构建话轮过程中持续出现言语障碍,每一次言语障碍都被会话对象发起修补,原本一个说话者一个话轮就能完成的会话,因为持续性他人修正使得话轮不断在会话双方之间转换,修正序列重复 6 次话轮构建才完成,会话序列被纵向扩张。第 22 行患者接受修正并继续当前话轮。但其当前话轮的构建十分费力,话轮中的找词标志语如"那个""那个叫"以及"呃"和"然后"都为患者找词准备时间,但同时也确保了话轮的连续性。"就这么些吧"标志着患者话轮/序列的结束。

## 5. 讨论

通过以上的语料分析,本文着重从话轮构建和序列结构两个方面探讨了失语症如何延迟会话进展,主要有以下发现:

### 5.1 失语症会话话轮的特殊性——自启修正致话轮延伸

自启修正一般由找词困难引出。对于单话轮构建单位组成的话轮,失语症说话者主要是通过延迟话轮单位内相关构建单位的输出或对单话轮的不断尝试,延迟话轮的结束



中国知网 https://www.cnki.net

进程。在多话轮构成单位的话轮构建中,失语症影响一方面延迟单个话轮构成单位内组成部分的输出,另一方面延迟说话者输出下一个话轮构建单位,从而拖长整个话轮结束的时间。患者用找词标志语如“嗯:”“呃:”“那个”,错语如“/diyuan/”“zou/”“/wangpan/”,感叹语如“谩骂”“哎呀”“哎”,笑声等填补话轮空缺,确保会话的连续性。如例 2“胳膊”和“这次”之间填充了感叹语“哎呀”和象声词“嘶”等;同一个话轮构建单位内也通过拖音如“胳:膊:”保持了会话连续性。无论是单话轮构建单位的扩展还是多话轮构建单位的延长,其本质都是患者自我修正的外部体现。国外学者前期对失语症的研究聚焦于患者如何自启修正(Wilkinson, 2007; Lakkso, 2014),但没有针对不同修正源及修正方式对话轮结构的影响进行探讨,本研究在前期研究的基础上探讨了自启修正如何延伸话轮结构,指出了失语症会话话轮的特殊性。

### 5.2 失语症会话序列的特殊性——他启修正致序列扩展

他启修正一般由理解或表达障碍触发。当患者自我修正失败或放弃自我修正时,会话的合作性(Laakso & Godt, 2016)要求会话对象进入患者话轮进行他人修正。不同于一般会话,失语症会话常伴随理解或言语障碍,一次修正往往不能直接解决问题,即使偶尔一次修正能解决问题,随着会话的进行,更多的问题出现,修正仍反复进行。在汉语语料中,他人修正通过两种方式扩展会话序列。其中一种是由于同一修正源持续不被理解引发的对同一问题的反复修正,另一种是会话过程中不断出现的修正源引发的对不同问题的多次修正。两种修正都在纵向上扩展了序列结构。如例 3 原本由“问题-答案”构成的最小相邻对序列答案不具备理解性而被后扩展,引发护士发起修正。由于修正源是错语,且此错语单独构成一个话轮,故其意思没有其他语境内容可供推测,导致多次修补(例 3;第 3,7,15,17,19 行),多次修正未果后,修补序列转为猜测序列(例 3;第 21-37 行)。两种会话行为在纵向上拉伸了序列结构,2 个话轮的最小序列被后扩展为 42 个话轮的序列结构。最小相邻对的第二部分不仅因反复修正被拖延,且直到 42 个话轮结束后也未果。同样在例 4 中,患者在构建话轮的过程中被他人修正多次打断(例 4;第 10,12,15,17,19,21 行),不同于例 3,在例 4 中伴随着话轮的推进,多个修正源出现,他人修正在每个修正源出现时都进行修正,本该由一个患者完成的话轮在三个会话者之间来回转换,扩展了当前会话的序列结构,延迟会话向序列结束位置的推进。同时,他人修正序列的出现强调会话对象在失语症会话中的特殊作用。如果没有会话对象的话轮序列,失语症患者自身很难构建可理解的话轮,当失语症患者失去自我修正能力时,会话对象能够参与修正,确保会话的互解性,从而促使失语症患者在会话中完成社会行为。本语料中因他人修正出现的授权-演绎序列(例 3;第 4-5 行,第 8-9 行,第 20-21 行,第 32-33 行),重复确认序列(例 3;第 35-38 行)以及猜测序列(例 3;第 21-37 行)等都强调了会话对象的作用。失语症患者仅能用动作表达思想时,会话对象用语言演绎出其动作内容,得到确认后会话继续;失语症患者回答问题后,会话对象会与失语症患者再次确认答案的准确性,得到确认后会话继续;修正序列失败后,会话对象仍未放弃失语症患者表达,而是通过猜测序列承



中国知网 https://www.cnki.net

担会话任务,帮助失语症患者完成找词。以上序列在日常会话中很少出现,凸显出失语症这种特殊会话中会话对象的独特作用,对日后失语症的干预治疗有启示作用(如,对会话对象针对性干预培训)(Lock et al., 2001)。前期对他人修正主要集中在序列结构研究(Lakkso & Klippi, 1999; Barnes & Ferguson, 2015; Beeke et al., 2020),研究内容以会话修正的方式为主,研究结论强调会话伙伴在修正序列中的作用。同先前研究,本研究通过分析会话中的他人修正,强调了会话对象的作用。但不同于先前研究,本文注重他人修正对序列结构的影响,从而阐述失语症会话的特殊性。

## 6. 结语

本文通过对汉语老年失语症互动语料的会话分析,揭示了会话分析在研究失语症沟通中的重要意义,会话分析作为一个独特的观察和分析人际互动的研究方法,能够为汉语环境下的临床话语及老年话语研究提供一个崭新的路径和视角,相关研究成果对于深入理解失语症患者语言与互动能力并为该特定人群提供临床干预及有效照护具有潜在的应用价值。目前,对于汉语环境下语障人群(尤其语障老年人群)的会话分析尚在起步阶段,临床语言学与会话分析的交叉研究领域(即临床会话分析, Clinical Conversation Analysis)亟待探索,希望本文能够起到抛砖引玉的作用。

**参考文献**

[1] Barnes, S. & A. Ferguson. Conversation partner responses to problematic talk produced by people with aphasia: Some alternatives to initiating, completing, or pursuing repair[J]. *Aphasiology*, 2015, 29(3): 315-336.

[2] Beeke, S., S. Capindale & L. Cockayne. Correction and turn completion as collaborative repair strategies in conversations following Wernicke's aphasia[J]. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 2020, 34(10-11): 933-953.

[3] Goffman, E. Footing[J]. *Semiotica*, 1979, 25(1-2): 1-30.

[4] Jefferson, G. Glossary of transcript symbols with an introduction[A]. In G. Lerner (ed.). *Conversation Analysis: Studies From the First Generation*[C]. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 13-31.

[5] Laakso, M. Aphasia sufferers' displays of affect in conversation[J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2014, 47(4): 404-425.

[6] Laakso, M. Collaborative participation in aphasic word searching: Comparison between significant others and speech and language therapists[J]. *Aphasiology*, 2015, 29(3): 269-290.

[7] Laakso, M. & A. Klippi. A closer look at the "hint and guess" sequences in aphasic conversation[J]. *Aphasiology*, 1999, 13(4-5): 345-363.

[8] Laakso, M. & S. Godt. Recipient participation in conversations involving participants with fluent or non-fluent aphasia[J]. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 2016, 30(10): 770-789.

[9] Law, S. P. et al. Effects of context and word class on lexical retrieval in Chinese speakers with anomic



中国知网 https://www.cnki.net

aphasia[J]. *Aphasiology*, 2015, 29(1): 81-100.

[10]Lesser, R. & L. Milroy. *Linguistics and Aphasia Psycholinguistic and Pragmatic Aspects of Intervention* [M]. New York: Routledge, 1993.

[11]Lock, S. et al. Supporting partners of people with aphasia in relationships and conversation (SPPARC) [J]. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2001, 36(1): 25-30.

[12]Sacks, H., E. A. Schegloff & G. Jefferson. A simplest systematics for the organization of turn taking for conversation[J]. *Language*, 1974, 50 (4): 696-735.

[13]Schegloff, E. A., G. Jefferson & H. Sacks. The preference for self-correction in the organization of repair in conversation[J]. *Language*, 1977, 53(2): 361-382.

[14]Schegloff, E. A. Turn organization: one intersection of grammar and interaction[A]. In E. Ochs, E. A. Schegloff & S. Thompson (eds.). *Interaction and Grammar*[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 52-133.

[15]Schegloff, E. A. *Sequence Organization in Interaction* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[16]Stivers, T. An overview of the question-response system in American English conversation[J]. *Journal of Pragmatics*, 2010, 42(10): 2772-2781.

[17]Wilkinson, R. Managing linguistic incompetence as a delicate issue in aphasic talk-in-interaction: On the use of laughter in prolonged repair sequences[J]. *Journal of Pragmatics*, 2007, 39(3): 542-569.

[18]Wilkinson, R., J. P. Rae & G. Rasmussen. *Atypical Interaction: The Impact of Communicative Impairments within Everyday Talk*[M]. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.

[19]Wilkinson, R., S. Beeke & J. Maxim. Adapting to conversation: On the use of linguistic resources by speakers with fluent aphasia in the construction of turns at talk[A]. In C. Goodwin (ed.). *Conversation and Brain Damage*[C]. Oxford: Oxford University Press, 2003. 59-89.

[20]崔刚. 失语症的语言学研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2002.

[21]高素荣. 失语症[M]. 北京:北京大学医学出版社,2006.

[22]马文. 会话照应语修正的语用原则[J]. 外语教学, 2003,(2): 40-43.

[23]王拥军等. 中国卒中报告 2019 (中文版)[J]. 中国卒中杂志, 2020, (12): 1251-1263.

[24]姚剑鹏. 会话自我修补中的语境化提示[J]. 山东外语教学,2016,(3):9-12.

(责任编辑:孙炬)



中国知网 https://www.cnki.net